

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Fiches QE Haute Fréquence — Version 1

Cross-match : 750 QEs officielles (Janvier 2018 → Normal 2026) × Cours officiel Gynéco-Obstétrique (PDF fourni) + corrections officielles e-qe.online

Banque de 750 QE — 15 sessions — Concours de Gynécologie-Obstétrique

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 750 QEs (15 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Hta Gravidique & Prééclampsie	45 Q	—
2	Tumeurs Du Sein	39 Q	—
3	Maladie Inflammatoire Pelvienne (Igh)	35 Q	—
4	Allo-Immunisation Fœto-Maternelle (Afm)	35 Q	—
5	Délivrance & Hémorragie Du Post-Partum	31 Q	—
6	Contraception	28 Q	—
7	Placenta Prævia	27 Q	—
8	Hématome Rétro-Placentaire (Hrp)	27 Q	—
9	Grossesse Extra-Utérine (Geu)	25 Q	—
10	Anomalies Du Liquide Amniotique	23 Q	—
11	Cardiopathie & Grossesse	22 Q	—
12	Cancer Du Col Utérin	21 Q	—
13	Diabète & Grossesse	20 Q	—
14	Présentation Du Siège	20 Q	—
15	Infection Urinaire & Grossesse (+ Situations Particulières)	19 Q	—
16	Suivi & Surveillance De La Grossesse	18 Q	—
17	Menace D'Accouchement Prématuro (Map) & Tocolyse	17 Q	—
18	Fibrome Utérin	17 Q	—
19	Grossesse Prolongée & Dépassement De Terme	16 Q	—
20	Grossesse Gémellaire / Multiple	16 Q	—
21	Asphyxie Périnatale & Rythme Cardiaque Fœtal (Rcf)	16 Q	—
22	Prolapsus Génital & Incontinence Urinaire D'Effort	14 Q	—
23	Endométriose	14 Q	—
24	Cancer De L'Endomètre	14 Q	—
25	Suites De Couches & Endométrite Du Post-Partum	14 Q	—
26	Rupture Prématuroe Des Membranes (Rpm)	13 Q	—

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
27	Mécanique Obstétricale & Exploration Du Bassin	12 Q	—
28	Présentation Du Sommet	12 Q	—
29	Tumeurs De L'Ovaire	12 Q	—
30	Présentations Céphaliques Défléchies (Face / Front)	12 Q	—
31	Cycle Menstruel, Puberté & Saignements Utérins Anormaux	12 Q	—
32	Travail Normal & Contractions Utérines	11 Q	—
33	Cancer De La Vulve & Lichen Scléreux	10 Q	—
34	Ménopause & Traitement Hormonal Substitutif	9 Q	—
35	Mort Fœtale In Utero (Mfiu)	9 Q	—
36	Hépatites Virales & Grossesse	9 Q	—
37	Aménorrhée (Primaire & Secondaire)	9 Q	—
38	Tuberculose Génitale Féminine	8 Q	—
39	Maladie Trophoblastique — Môle Hydatiforme	8 Q	—
40	Toxoplasmose & Grossesse	8 Q	—
41	Accouchement Sur Utérus Cicatriciel	6 Q	—
42	Présentation De L'Épaule (Transverse)	5 Q	—
43	Procidence Du Cordon	3 Q	—
44	Rubéole & Grossesse	2 Q	—
45	Syphilis & Grossesse	2 Q	—
46	Mortalité Maternelle	2 Q	—
47	Retard De Croissance Intra-Utérin (Rciu)	2 Q	—

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 15 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Hta Gravidique & Prééclampsie	45	3.00	6.0%
Tumeurs Du Sein	39	2.60	5.2%
Maladie Inflammatoire Pelvienne (Igh)	35	2.33	4.7%
Allo-Immunsisation Fœto-Maternelle (Afm)	35	2.33	4.7%
Délivrance & Hémorragie Du Post-Partum	31	2.07	4.1%
Contraception	28	1.87	3.7%
Placenta Prævia	27	1.80	3.6%
Hématome Rétro-Placentaire (Hrp)	27	1.80	3.6%
Grossesse Extra-Utérine (Geu)	25	1.67	3.3%
Anomalies Du Liquide Amniotique	23	1.53	3.1%
Cardiopathie & Grossesse	22	1.47	2.9%
Cancer Du Col Utérin	21	1.40	2.8%
Diabète & Grossesse	20	1.33	2.7%
Présentation Du Siège	20	1.33	2.7%
Infection Urinaire & Grossesse (+ Situations Particulières)	19	1.27	2.5%
Suivi & Surveillance De La Grossesse	18	1.20	2.4%
Menace D'Accouchement Prématuro (Map) & Tocolyse	17	1.13	2.3%
Fibrome Utérin	17	1.13	2.3%
Grossesse Prolongée & Dépassement De Terme	16	1.07	2.1%
Grossesse Gémellaire / Multiple	16	1.07	2.1%
Asphyxie Périnatale & Rythme Cardiaque Fœtal (Rcf)	16	1.07	2.1%
Prolapsus Génital & Incontinence Urinaire D'Effort	14	0.93	1.9%
Endométriose	14	0.93	1.9%
Cancer De L'Endomètre	14	0.93	1.9%
Suites De Couches & Endométrite Du Post-Partum	14	0.93	1.9%
Rupture Prématuroe Des Membranes (Rpm)	13	0.87	1.7%
Mécanique Obstétricale & Exploration Du Bassin	12	0.80	1.6%
Présentation Du Sommet	12	0.80	1.6%
Tumeurs De L'Ovaire	12	0.80	1.6%
Présentations Céphaliques Défléchies (Face / Front)	12	0.80	1.6%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Cycle Menstruel, Puberté & Saignements Utérins Anormaux	12	0.80	1.6%
Travail Normal & Contractions Utérines	11	0.73	1.5%
Cancer De La Vulve & Lichen Scléreux	10	0.67	1.3%
Ménopause & Traitement Hormonal Substitutif	9	0.60	1.2%
Mort Fœtale In Utero (Mfiu)	9	0.60	1.2%
Hépatites Virales & Grossesse	9	0.60	1.2%
Aménorrhée (Primaire & Secondaire)	9	0.60	1.2%
Tuberculose Génitale Féminine	8	0.53	1.1%
Maladie Trophoblastique — Môle Hydatiforme	8	0.53	1.1%
Toxoplasmose & Grossesse	8	0.53	1.1%
Accouchement Sur Utérus Cicatriciel	6	0.40	0.8%
Présentation De L'Épaulé (Transverse)	5	0.33	0.7%
Procidence Du Cordon	3	0.20	0.4%
Rubéole & Grossesse	2	0.13	0.3%
Syphilis & Grossesse	2	0.13	0.3%
Mortalité Maternelle	2	0.13	0.3%
Retard De Croissance Intra-Utérin (Rciu)	2	0.13	0.3%
TOTAL (47 leçons identifiées)	749 Q	49.9	99.9%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] HTA GRAVIDIQUE & PRÉÉCLAMPSIE

— • ~3.00 Q/examen

Définition de la prééclampsie (PE) :

- HTA gravidique (TA $\geq$ 140/90 mmHg) + protéinurie ($\geq$ 0,3 g/24h), apparues APRÈS 20 SA
- Disparaît après l'accouchement (seul traitement curatif = arrêt de la grossesse)
- Survient surtout chez la PRIMIPARE
- Mécanisme = ischémie placentaire par défaut d'invasion trophoblastique $\rightarrow$ $\uparrow$ résistances vasculaires
- C'est l'une des 1res causes de mortalité maternelle au Maroc
- Δ Les œdèmes des membres inférieurs NE sont PAS obligatoires au diagnostic
- Δ Ne survient PAS au 1er trimestre
- Δ N'est PAS « due à une maladie rénale » et ne touche PAS surtout la multipare

□ Récurent — vu ~12x (2018→2026)

Signes CLINIQUES de gravité :

- Céphalées (en casque), barre épigastrique (douleur de Chaussier)
- Acouphènes / bourdonnements d'oreille, phosphènes
- Oligurie, ROT vifs ; TA $\geq$ 160/110 = HTA sévère
- Δ PIÈGE classique : les œdèmes des MI ne sont PAS un signe de gravité
- Δ TA $\geq$ 140/90 seule = critère de DÉFINITION, pas de gravité

□ Vu ~8x (N25, Jt24, O24, J24, J23, J22...)

Signes PARACLINIQUES de gravité :

- Thrombopénie ($< 100\,000/\text{mm}^3$)
- Cytolyse hépatique ; hémolyse
- Hyperuricémie ; oligurie $< 500\text{ cc}/24\text{h}$; hémococoncentration (Hte élevé)
- Protéinurie massive
- Δ PIÈGE : une protéinurie à 0,3 g/24h = seuil DIAGNOSTIQUE et non de gravité
- Δ La glycémie, la cholestérolémie et la natrémie n'évaluent PAS la gravité ($\rightarrow$ uricémie + protéinurie)

□ Vu ~7x (N25, J24, J23, J21...)

HELLP syndrome :

- H = Hémolyse, EL = Elevated Liver enzymes (cytolyse), LP = Low Platelets (thrombopénie)
- Complication de la PE ; mortalité maternelle élevée
- Δ N'est PAS défini par un βHCG élevé
- Δ PAS de lithiase vésiculaire, PAS d'hyperleucocytose, PAS d'ictère rétionnel

□ Vu : Ratt25, J20, J19, J18

Traitement de la prééclampsie :

- Antihypertenseurs : alpha-méthyl-dopa, β -bloquants (labétalol), inhibiteurs calciques (nicardipine)
- Anticonvulsivants (sulfate de magnésium) en cas de gravité / éclampsie
- Repos ; extraction fœtale = seul traitement curatif (déclenchement / césarienne selon terme et gravité)
- Arrêt de grossesse possible après 37 SA
- Δ CONTRE-INDIQUÉS : diurétiques, IEC (téatogènes)
- Δ PAS de régime hyposodé strict (régime normosodé)
- Δ PAS de césarienne systématique ; PAS de déclenchement « quel que soit le terme »

□ Récurent — vu ~9x

Complications materno-fœtales :

- Fœtales : RCIU, oligoamnios, souffrance fœtale chronique, MFIU
- Maternelles : éclampsie (convulsions), OAP, insuffisance rénale aiguë, HRP, HELLP, accouchement prématuré
- **⚠ PAS de macrosomie (au contraire : RCIU)**
- **⚠ L'anasarque fœto-placentaire relève de l'allo-immunisation, pas de la PE**
- **⚠ L'ictère néonatal n'est PAS une complication classique**

□ Vu ~7× (Ratt25, J24, J23, J21, J18)

[RANG 2] TUMEURS DU SEIN

— • ~2.60 Q/examen

□ Classification TNM — bénin (adénofibrome, kyste, phyllode) vs malin (CCI)

Orientation diagnostique d'un nodule du sein :

- Triade diagnostique : examen clinique + imagerie (mammographie + échographie) + microbiopsie histologique
- Chez la femme ménopausée/âgée avec nodule dur → évoquer en 1er le carcinome mammaire
- Nodule solide chez la femme jeune : adénofibrome, phyllode, carcinome, voire lymphome
- **⚠ La thermographie, la lymphographie, la TDM mammaire et la galactographie ne sont PAS des examens de 1re intention**
- **⚠ La palpation seule ne confirme JAMAIS la malignité (→ histologie)**

□ Récurrent (cas cliniques répétés N26→J18)

Mammographie & signes de malignité :

- Meilleur test de DÉPISTAGE ; dépistage organisé à partir de 50 ans
- Signes malins : opacité stellaire/spiculée, contours irréguliers, aspect rétractile, microcalcifications suspectes
- Échographie maligne : hypoéchogène, contours irréguliers, atténuation postérieure, grand axe perpendiculaire à la peau
- BIRADS 4 ou 5 → microbiopsie (preuve histologique) s'impose
- **⚠ Une seule incidence ne suffit PAS ; les microcalcifications ne sont pas TOUJOURS suspectes**
- **⚠ Macrocalcifications et limites régulières = plutôt bénin**

□ Vu ~6× (N26, O24, Jn21...)

Biopsie « grasseuse sans cellules tumorales » sur nodule cliniquement suspect :

- Discordance radio-histologique → REFAIRE la biopsie SANS attendre
- **⚠ Ne PAS rassurer ni recontrôler à 3 mois ; ne pas opérer d'emblée sans preuve**

□ Vu : O24, Jn21, J19 (récurrent)

Facteurs de risque du cancer du sein :

- Antécédents familiaux (1er degré, surtout âge jeune) ; nulliparité ; absence d'allaitement
- Cancer hormono-dépendant ; ménopause TARDIVE
- Prédisposition familiale ≈ 5 % des cas
- **⚠ La ménopause PRÉCOCE n'est PAS un FdR (c'est la ménopause tardive)**
- **⚠ Un apparenté au 2nd degré et âgé pèse moins qu'une mère atteinte jeune**

□ Vu : Jn23, J20, J19

Carcinome canalaire infiltrant — dissémination & traitement :

- Dissémination lymphatique PRÉCOCE, progressive et = facteur pronostique majeur
- Traitement conservateur (tumorectomie in sano + ganglion sentinelle/curage + radiothérapie) si tumeur < 3 cm
- Mastectomie ± curage si tumeur volumineuse ; chimiothérapie néoadjuvante possible
- **⚠ La dissémination lymphatique n'est PAS « toujours présente » ni exceptionnelle**
- **⚠ La chimiothérapie n'est PAS toujours indiquée**

□ Vu ~5×

Tumeur phyllode & adénofibrome :

- Phyllode : bénigne OU maligne, croissance rapide, récurrences fréquentes → exérèse large / mastectomie
- Adénofibrome : bénin, femme jeune, aspect échographique évocateur ; tumorectomie si gênant
- Maladie fibrokystique : femme jeune nullipare, mastodynies, écoulement
- ⚠ *La phyllode n'est PAS épithéliale et n'est PAS très lymphophile*
- ⚠ *L'adénofibrome ne touche PAS « les femmes âgées » et ne justifie ni mastectomie ni IRM systématique*

□ Vu : N26, J22

[RANG 3] MALADIE INFLAMMATOIRE PELVIENNE (IGH)

— • ~2.33 Q/examen

Tableau clinique de l'infection génitale haute (IGH/MIP) :

- Tableau typique : syndrome infectieux franc + douleurs pelviennes + leucorrhées purulentes/nauséabondes + douleur à la mobilisation utérine
- Les formes asymptomatiques/torpidées sont fréquentes ; peut être découverte sur un bilan d'infertilité
- Examen : leucorrhées louches, TV douloureux, empatement/douleur des culs-de-sac, douleur à la mobilisation cervico-utérine
- ⚠ *Le tableau n'est PAS « souvent typique » (formes frustes fréquentes)*
- ⚠ *Le diagnostic de certitude NE repose PAS sur l'échographie*
- ⚠ *Des lactobacilles abondants au microscope vont CONTRE le diagnostic (flore normale)*

□ Récurrent (Jt24, Nv24, J24, Jn23...)

Germes responsables :

- Chlamydia trachomatis = le plus fréquent ; Neisseria gonorrhoeae
- Péri-hépatite (sd de Fitz-Hugh-Curtis) → Chlamydia + gonocoque
- ⚠ *Le streptocoque, le BK et le Proteus ne sont PAS les germes habituels*

□ Vu : N26, O24

Facteurs de risque & circonstances de survenue :

- Deux grandes circonstances : IST et gestes endo-utérins
- FdR : jeune âge, précocité/multiplicité des partenaires, partenaire récent, rapports non protégés, urétrite du partenaire, ATCD d'IST
- ⚠ *Femme âgée et haut niveau socio-économique NE sont PAS des FdR*

□ Vu : O24, J24

Examens complémentaires & abcès pelvien :

- TOUS les examens (NFS, CRP, échographie, scanner, BU) peuvent être NORMAUX en cas d'IGH
- Abcès pelvien (pyosalpinx, abcès tubo-ovarien, abcès du Douglas) : complication de l'IGH ; dgc écho + coelioscopie
- Traitement de l'abcès = drainage chirurgical + antibiothérapie
- ⚠ *Le traitement médical seul n'est PAS suffisant pour un abcès constitué*

□ Vu : N26, N25, Jt24, J23

Antibiothérapie de l'IGH :

- Bi/tri-antibiothérapie couvrant Chlamydia + gonocoque + anaérobies (ex. C3G + doxycycline ± métronidazole)
- Préservatif = moyen protecteur contre les IST
- ⚠ *La doxycycline seule est insuffisante*

□ Vu : Jn23

[RANG 4] ALLO-IMMUNISATION FŒTO-MATERNELLE (AFM)

— • ~2.33 Q/examen

Physiopathologie de l'AFM :

- Passage des hématies fœtales dans la circulation maternelle, MAXIMAL pendant l'accouchement
- Systèmes en cause : Rhésus D mais aussi c, E et Kell
- Incompatibilité ABO : peut donner une anémie/hémolyse néonatale (jamais d'anasarque)
- ⚠ *Les anticorps de la 1re grossesse ne sont PAS des IgA (réponse primaire IgM puis IgG ; ce sont les IgG qui passent le placenta)*

□ Récurrent — vu ~8×

Doppler de l'artère cérébrale moyenne (ACM) :

- Mesuré sur l'artère cérébrale moyenne fœtale
- Apprécie le degré d'ANÉMIE fœtale (corrélé) ; a révolutionné la prise en charge
- Aide à la décision d'extraction — examen NON invasif
- ⚠ *Il n'est PAS invasif et n'est PAS corrélé à l'anémie MATERNELLE (mais fœtale)*

□ Vu : O24, Jn21

Prévention par immunoglobulines anti-D (femme Rh négatif) :

- Systématique à 28 SA
- Après toute situation à risque d'hémorragie fœto-maternelle : môle, GEU, traumatisme abdominal, fausse couche, cerclage, amniocentèse
- Systématique à la naissance si le nouveau-né est Rh positif
- ⚠ *Ne se fait PAS « uniquement si RAI positifs » (au contraire, on protège quand les RAI sont négatives)*
- ⚠ *Items de session piège : selon l'énoncé, le mois de prévention varie (3e/5e/7e mois) — retenir 28 SA*

□ Récurrent — formulations variables

Prise en charge de l'AFM déclarée :

- Le doppler cérébral permet d'apprécier le degré d'anémie fœtale → guide la décision
- ⚠ *L'amniocentèse/cordocentèse n'est PAS obligatoire avant toute décision*
- ⚠ *La décision d'extraction ne repose PAS uniquement sur le titrage des anticorps*
- ⚠ *Il ne faut PAS attendre l'anasarque pour extraire*
- ⚠ *L'extraction ne se fait PAS obligatoirement par césarienne*

□ Récurrent — réponse = B seule (~9×)

[RANG 5] DÉLIVRANCE & HÉMORRAGIE DU POST-PARTUM

— • ~2.07 Q/examen

Hémorragie de la délivrance (HPP) — conduite à tenir :

- Révision utérine SYSTÉMATIQUE
- Chirurgie d'emblée possible si état hémodynamique critique
- Examen sous valves pour rechercher une déchirure cervico-vaginale
- ⚠ *Ne pas tirer (traction) sur le cordon pour accélérer la délivrance*
- ⚠ *L'examen sous valves n'est pas à omettre même si on suspecte une inertie*

□ Vu : O24

Absence de délivrance 30 min après l'accouchement :

- Délivrance artificielle systématique (rétention placentaire)
- ⚠ *L'expectative n'est PAS de mise au-delà de 30 min ; le risque hémorragique n'est pas négligeable*

□ Vu : O24

Facteurs de risque d'HPP par inertie/atonie utérine :

- Surdistension : grossesse gémellaire, macrosomie, hydramnios
- Travail prolongé, multiparité
- *⚠ La cicatrice utérine et la présentation du siège ne sont PAS des FdR d'inertie ; le dépassement de terme non plus*

□ Vu : O24, J19

Avortements spontanés du 1er trimestre :

- L'avortement « en cours » est de diagnostic clinique
- Bilan étiologique systématique en cas d'avortements À RÉPÉTITION
- Vérification échographique après expulsion ; prophylaxie anti-D à considérer si Rh négatif
- *⚠ Les causes utérines ne sont PAS les plus fréquentes (>> causes chromosomiques)*
- *⚠ Les métrorragies ne sont pas constantes ; l'examen anatomopathologique n'est pas systématique sur un avortement isolé*

□ Vu : O24, J23, J18

Endométrite du post-partum :

- Signes : douleurs à la mobilisation utérine, col utérin (douleur), lochies fétides ± fièvre
- Se déclare souvent vers J4–J5 ; antibiothérapie indispensable
- Complications : abcès pelvien, pelvipéritonite, synéchie, pyosalpinx
- *⚠ Un globe utérin tonique va contre l'endométrite (utérus mal involué) ; la défense abdominale généralisée signe une péritonite, pas une endométrite simple*

□ Vu : O24, J22, J19

Consignes de sortie après accouchement par voie basse :

- Rééducation périnéale débutée ~6–8 semaines après l'accouchement
- *⚠ Pas d'antibiothérapie systématique pour une simple épisiotomie ; pas d'œstroprogestatif à 2 semaines (risque thrombo-embolique du post-partum) ; supplémentation en calcium non systématique*

□ Vu : O24, Jn21

[RANG 6] CONTRACEPTION

— • ~1.87 Q/examen

Méthodes œstroprogestatives (COP) vs progestatifs seuls :

- Œstroprogestatif : pilule combinée/minidosée, anneau vaginal, patch — prise 21 j puis 7 j d'arrêt
- Progestatifs seuls : microprogestatifs, progestatifs injectables, implant, DIU au lévonorgestrel
- *⚠ L'IMPLANT n'est PAS un œstroprogestatif ; la pilule combinée n'est PAS un progestatif seul*

□ Récurrent (Ratt25, J21, Jn23...)

Contraception réversible de longue durée (LARC) :

- LARC = implant, DIU (cuivre et hormonal) ; longue durée d'action
- L'anneau vaginal agit par effet anti-gonadotrope
- *⚠ Les microprogestatifs oraux ne sont PAS des LARC (prise quotidienne)*

□ Vu : Ratt25, J24

Contre-indications & antécédents :

- Les 2 grandes CI de la contraception HORMONALE : ATCD de thrombose veineuse et ATCD de cancer du sein
- Pilules de 3e génération : AUGMENTENT le risque thromboembolique → pas en 1re intention
- Rifampicine : inducteur enzymatique → RÉDUIT l'efficacité (surtout minidosées)
- *⚠ Un ATCD personnel de cancer du sein EST une contre-indication (proposition « n'est pas une CI » = FAUSSE)*
- *⚠ La contraception d'urgence est autorisée chez la mineure*

□ Récurrent — vu ~6×

Mécanisme d'action de la pilule combinée :

- Inhibition de l'ovulation, rétrocontrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire, modification de la glaire cervicale, modification de l'endomètre
- **⚠ L'« inflammation de l'endomètre » N'est PAS un mécanisme de la pilule combinée**

□ Vu : Ratt25, Jn23

Efficacité & 1re intention :

- Méthode TOUJOURS très efficace selon l'OMS = DIU
- COP de 2e génération recommandée en 1re intention chez la femme jeune sans ATCD
- Implant : valable ~3 ans, posé en début de cycle, peut donner une spanioménorrhée
- **⚠ Le préservatif et les spermicides ne sont pas les plus efficaces ; seul le préservatif protège des IST**

□ Vu : J23, J18, N25

[RANG 7] PLACENTA PRÆVIA

— • ~1.80 Q/examen

Définition & présentation clinique :

- Insertion basse du placenta ; métrorragies de sang ROUGE, indolores, récidivantes
- Favorisé par les curetages, la cicatrice utérine, le tabac, la grossesse multiple, la multiparité
- Expose à la prématurité, aux anomalies de présentation et au placenta accreta
- **⚠ Sang ROUGE (pas noirâtre) ; n'est PAS toujours une indication de césarienne (selon recouvrement et saignement)**
- **⚠ La primiparité n'est PAS un FdR ; pas de macrosomie ni d'hydramnios spécifiques**

□ Récurrent (N26, N25, Ratt25)

Métrorragies du 3e trimestre — geste à PROSCRIRE :

- Devant une hémorragie sur grossesse avancée : voie veineuse + remplissage, NFS/groupage + demande de sang, ÉCHOGRAPHIE obstétricale (diagnostic)
- **⚠ Le TOUCHER VAGINAL est CONTRE-INDIQUÉ (risque d'hémorragie cataclysmique) — piège récurrent**

□ Vu ~6× (Jt24, O24, Nv24)

Placenta praevia recouvrant à terme avec saignement :

- Mise en condition + césarienne en urgence si placenta totalement recouvrant et/ou hémorragie
- La prise en charge dépend de l'importance du saignement et de l'âge gestationnel
- **⚠ Ne pas tenter la voie basse sur un placenta totalement recouvrant ; ne pas rompre la poche des eaux**

□ Vu : Jt24, O24, N25

[RANG 8] HÉMATOME RÉTRO-PLACENTAIRE (HRP)

— • ~1.80 Q/examen

Définition & signes cliniques de l'HRP :

- Décollement prématuré d'un placenta NORMALEMENT inséré ; urgence materno-fœtale
- Triade : douleur abdominale brutale « en coup de poignard », contracture utérine (« utérus de bois »), métrorragies noirâtres peu abondantes
- BCF souvent négatifs (MFIU) ; souffrance fœtale aiguë ; complice souvent une prééclampsie
- **⚠ Placenta NORMALEMENT inséré (≠ placenta praevia)**
- **⚠ Hémorragie souvent NON extériorisée / faible au regard de l'état de choc**
- **⚠ L'HRP menace LA MÈRE ET le fœtus (pas seulement le fœtus)**

□ Récurrent — vu ~8×

Étiologies & facteurs de risque :

- Cause la plus fréquente : ischémie utéro-placentaire / prééclampsie
- Autres FdR : thrombophilie, âge maternel avancé, RCIU, traumatisme, décompression brutale d'un hydramnios
- ⚠ *La prééclampsie n'est PAS la SEULE étiologie de l'HRP*

□ Vu : J19, J18

Complications :

- CIVD et troubles de l'hémostase, inertie utérine, insuffisance rénale aiguë, MFIU, apoplexie utéro-placentaire de Couvelaire
- ⚠ *Bilan d'hémostase indispensable AVANT la décision ; le traitement n'est PAS médical (obstétrical/chirurgical)*

□ Récurrent (souvent « tout est juste »)

Mode d'accouchement & prise en charge :

- Voie basse possible si fœtus VIVANT à dilatation complète et engagé, OU fœtus mort SANS trouble de coagulation
- Objectifs : traiter le choc/hypovolémie, évacuer l'utérus quel que soit le terme, corriger l'hémostase
- Césarienne en urgence si fœtus vivant non extractible rapidement
- ⚠ *Voie basse à éviter si fœtus vivant avec troubles de coagulation ou utérus doublement cicatriciel*

□ Vu : J24, Jt24, J18

[RANG 9] GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE (GEU)

— • ~1.67 Q/examen

Facteurs de risque & localisation :

- FdR : ATCD d'IST/salpingite chronique, chirurgie tubaire, infertilité, endométriose, DIU, âge > 40 ans, tabac
- Localisation la plus fréquente = AMPULLAIRE (trompe)
- La rupture est plus fréquente dans la localisation isthmique
- ⚠ *La localisation isthmique/pavillonnaire n'est PAS la plus fréquente*
- ⚠ *N'évolue PAS toujours vers la rupture et le traitement n'est PAS toujours chirurgical*

□ Récurrent — vu ~7×

Suspicion de GEU avec examen clinique NORMAL :

- Conduite : dosage des β HCG plasmatiques + échographie endovaginale (pelvienne)
- ⚠ *Pas de laparotomie ni de coelioscopie « en urgence » d'emblée si l'examen est normal et la patiente stable*
- ⚠ *Ne pas reconvoquer à 1 semaine sans bilan*

□ Récurrent — réponse B,D (~8×

β HCG > 1000–1500 UI/L + utérus vide à l'échographie endovaginale :

- Évoque : GEU, grossesse intra-utérine débutante (juste sous le seuil de visibilité) ou grossesse arrêtée
- Signes écho de GEU : utérus vide, masse latéro-utérine, épanchement péritonéal, pseudo-sac intra-utérin
- ⚠ *Un vrai sac intra-utérin avec activité cardiaque ÉLIMINE la GEU*
- ⚠ *Un kyste de l'ovaire ne donne pas ce tableau hormonal*

□ Vu : J24, J23, O24

Hématocèle rétro-utérine (GEU rompue collectée) :

- Masse du cul-de-sac de Douglas, douleur pelvienne, anémie, dysurie $\pm$ état de choc
- ⚠ *Tableau d'urgence chirurgicale (forme évoluée de GEU)*

□ Vu : N26, Ratt25, J18

[RANG 10] ANOMALIES DU LIQUIDE AMNIOTIQUE

— • ~1.53 Q/examen

Formation/résorption du liquide amniotique (LA) :

- Production principale = diurèse fœtale ; résorption principale = DÉGLUTITION fœtale
- Le placenta et le cordon participent à la formation du LA
- Production excessive possible si trouble de la déglutition (ex. myéloméningocèle, atrésie de l'œsophage)
- *⚠ La déglutition est la voie de RÉSORPTION (les items « principale voie de production = déglutition » sont des pièges fréquents)*

□ Récurrent — vu ~10×

Oligoamnios :

- Grande citerne < 2 cm OU index amniotique < 5 cm
- Rechercher systématiquement une RPM ; mesurer TA + protéinurie (PE)
- Étiologies fœtales : agénésie/hypoplasie rénale, uropathie obstructive, RCIU/insuffisance placentaire
- Complication : hypoplasie pulmonaire ; le pronostic dépend de la quantité
- *⚠ Le diabète maternel et l'insuffisance placentaire ne sont pas des causes « fœtales » au sens strict*
- *⚠ Index < 8 cm = limite basse (les seuils piégés 4–5 cm reviennent selon les sessions)*

□ Récurrent — vu ~9×

Syndrome de Potter / Hydramnios :

- Potter : séquence liée à l'oligoamnios sévère → faciès de Potter, déformations des membres, hypoplasie pulmonaire
- Hydramnios : grande citerne > 8 cm / index > 25 cm ; peut être compressif ; rechercher diabète, atrésie œsophagienne, anomalies neuro
- *⚠ Le syndrome de Potter n'est pas un « syndrome génétique » au sens chromosomique et n'impose pas systématiquement la césarienne*

□ Vu : N25, Ratt25, J23, J18

[RANG 11] CARDIOPATHIE & GROSSESSE

— • ~1.47 Q/examen

□ Pronostic = stade NYHA de la dyspnée

Modifications cardiovasculaires de la grossesse normale :

- Augmentation du volume plasmatique → anémie physiologique de dilution
- Augmentation du débit cardiaque ; baisse de la TA au 1er trimestre
- État d'HYPERcoagulabilité (↑ facteurs de la coagulation, ↓ viscosité)
- *⚠ Le débit cardiaque ne « reste pas stable » ; il n'y a PAS d'hypocoagulabilité (au contraire)*
- *⚠ La TA ne monte pas dès le 1er trimestre (elle baisse)*

□ Vu ~6× (N25, Ratt25, J23, J21)

Cardiopathie & grossesse — pronostic et risques :

- Pronostic corrélé au stade NYHA de la dyspnée
- Risque thromboembolique majoré ; consultation préconceptionnelle améliore le pronostic
- Le rétrécissement mitral est la cardiopathie la plus fréquente ; le rétrécissement aortique est mal toléré
- Complications : OAP, insuffisance cardiaque, RCIU, prématurité
- *⚠ L'accouchement par voie basse n'est PAS contre-indiqué en règle (privilegié si bien toléré, avec analgésie péridurale)*
- *⚠ La délivrance/post-partum EST une période à risque (pas « aucun risque »)*

□ Récurrent — vu ~8×

Post-partum chez la cardiaque :

- Risque thromboembolique MAJEUR → anticoagulation par HBPM
- Allaitement possible si cardiopathie bien tolérée ; contraception efficace nécessaire
- Cardiopathie stade IV / cardiomyopathie évolutive → IMG à discuter, prise en charge multidisciplinaire
- **⚠ Le risque infectieux d'endocardite n'est PAS « minime » (item piège récurrent)**

□ Récurrent — vu ~6×

[RANG 12] CANCER DU COL UTÉRIN

— • ~1.40 Q/examen

□ Classification FIGO du cancer du col

Facteur causal & dépistage :

- Cause = HPV oncogène, surtout types 16 et 18
- Dépistage : frottis cervico-utérin + test HPV ; IVA (inspection visuelle à l'acide acétique) et colposcopie pour la détection précoce
- **⚠ Le tabac est un cofacteur, pas LE facteur causal ; HPV 6 = non oncogène (condylomes)**
- **⚠ Le PET-scanner, l'hystéroscopie et l'échographie endovaginale ne sont PAS des outils de dépistage**

□ Récurrent (Jn23, J22, J19)

Diagnostic de confirmation :

- Confirmation = BIOPSIE du col avec étude anatomopathologique (ou pièce de conisation)
- **⚠ Ni le frottis, ni l'IVA, ni le test HPV ne CONFIRMENT le diagnostic (ce sont des outils de dépistage)**

□ Vu : J18

Stade IB1 (FIGO) :

- Tumeur LIMITÉE au col utérin ; bon pronostic
- Traitement : hystérectomie élargie (Wertheim) + lymphadénectomie ; radiothérapie possible
- **⚠ Ce n'est PAS un stade pré-invasif/in situ ; il n'est PAS étendu aux paramètres (= stade II) ; ne nécessite PAS toujours de chimiothérapie**

□ Récurrent — vu ~7×

Signes cliniques & épidémiologie :

- Métrorragies provoquées (post-coïtales), leucorrhées sanglantes, ulcération/lésion exophytique saignant au contact
- Le carcinome ÉPIDERMOÏDE est le type le plus fréquent ; traitement avancé = radio-chimiothérapie ± chirurgie
- **⚠ L'adénocarcinome n'est PAS le type le plus fréquent du col ; la lésion précancéreuse est la dysplasie/CIN (pas la métaplasie)**

□ Vu : J22, J18

[RANG 13] DIABÈTE & GROSSESSE

— • ~1.33 Q/examen

Diabète gestationnel (DG) — définition & dépistage :

- DG = tout trouble de la glycémie diagnostiqué POUR LA PREMIÈRE FOIS pendant la grossesse
- HLP (hormone lactogène placentaire) → insulino-résistance au 2e trimestre ; le glucose traverse le placenta, pas l'insuline
- Tendance à l'HYPOGlycémie au 1er trimestre (~10–14 SA)
- **⚠ Définition indépendante du recours ou non à l'insuline et du chiffre glycémique**
- **⚠ La glycosurie est un mauvais moyen de surveillance**

□ Récurrent (N26, Jn23, J21)

Complications maternelles & fœtales :

- Maternelles : HTA gravidique/prééclampsie, césariennes plus fréquentes, infection urinaire, MAP
- Fœtales/néonatales : MACROSOMIE, dystocie des épaules, hypoglycémie, hypocalcémie, ictère, détresse respiratoire, MFIU
- Malformations congénitales si diabète préexistant mal équilibré en périconceptionnel (HbA1c élevée)
- *⚠ Le DG donne une MACROSOMIE (pas un RCIU) ; le DG n'augmente pas le risque de grossesse gémellaire*
- *⚠ Le bon contrôle glycémique réduit les complications (donc une macrosomie traduit un mauvais équilibre)*

□ Récurrent — vu ~8×

Diabète préexistant : bilan, insuline, malformations :

- Type 1 : équilibre par INSULINE (régime + insuline) ; HbA1c à 9 % en périconceptionnel → risque malformatif majeur (cardiaque, SNC, rénal, membres, régression caudale)
- Besoins en insuline : ↓ en début de grossesse, ↑ au 2e/3e trimestre, ↓ dans le post-partum
- Bilan de microangiopathie : FO, créatinine, protéinurie 24h, ECG ; échographie morphologique 18–22 SA (gênée par l'obésité)
- *⚠ Pas d'hypoglycémifiants oraux/biguanides seuls pour le type 1 ; allaitement NON contre-indiqué ; césarienne non systématique*
- *⚠ La meilleure échographie morphologique n'est pas à 32–36 SA*

□ Vu : J24, J23, Jn23

[RANG 14] PRÉSENTATION DU SIÈGE

— • ~1.33 Q/examen

□ Repère = sacrum ; diamètre d'engagement = bitrochantérien (~9,5 cm)

Caractéristiques de la présentation du siège :

- Présentation dystocique ; repère = sacrum ; diamètre d'engagement = bitrochantérien (~9,5 cm)
- Étiologie fréquente = prématurité ; aussi malformation utérine
- Diagnostic surtout clinique (palper + TV) ; accouchement par voie basse possible sous conditions
- *⚠ NE nécessite PAS « toujours » une césarienne et ne se complique PAS « toujours » de souffrance fœtale aiguë*
- *⚠ Le repère n'est PAS le coccyx ; l'accouchement n'est pas « toujours » dystocique au sens d'impossible*

□ Récurrent — vu ~9×

Facteurs de mauvais pronostic / indications de césarienne :

- Bassin limite/rétréci, tête fœtale DÉFLÉCHIE, macrosomie, utérus cicatriciel, primiparité, obésité maternelle
- BIP élevé (~110 mm) = mauvais pronostic ; indications de césarienne : bassin anormal, déflexion primitive de la tête, utérus bi-cicatriciel
- *⚠ L'HYPERflexion de la tête est FAVORABLE (c'est la déflexion qui est péjorative)*
- *⚠ Une taille maternelle normale (165 cm) et un terme de 39 SA ne sont pas péjoratifs*

□ Récurrent — vu ~8×

Conduite de l'accouchement du siège par voie basse :

- Dilatation harmonieuse exigée ; expulsion ne devant pas dépasser ~30 min
- *⚠ Les ocytociques ne sont pas formellement interdits ; l'analgésie péridurale n'est pas contre-indiquée ; pas de rupture systématique des membranes à 3 cm*

□ Vu : Jt24, Nv24

[RANG 15] INFECTION URINAIRE & GROSSESSE (+ situations particulières)

— • ~1.27 Q/examen

Bactériurie asymptomatique & pyélonéphrite gravidique :

- ECBU $\geq 10^5$ germes/mL sans symptôme = bactériurie asymptomatique → à traiter (risque ~10–30 % d'évolution vers la pyélonéphrite)
- Germe le plus fréquent = Escherichia coli ; principal risque si non traitée = accouchement prématuré
- Pyélonéphrite : fièvre $\pm$ frissons, signes urinaires, douleur lombaire (souvent droite), parfois fièvre isolée → hospitalisation, C3G
- *⚠ Une bactériurie asymptomatique n'est PAS un « résultat normal » chez la femme enceinte*
- *⚠ Éviter sulfamides et fluoroquinolones ; FdR : ATCD de PNA, uropathies, diabète, infection cervico-vaginale (pas la prééclampsie)*

□ Vu : J24, Jn23, J21, J18

Grossesse & VIH/SIDA :

- Conduite obstétricale selon la CHARGE VIRALE : si indétectable → voie basse possible ; si charge élevée → césarienne
- Traitement antirétroviral POURSUIVI pendant la grossesse ; antirétroviraux au nouveau-né dès la naissance
- Allaitement déconseillé/contre-indiqué
- *⚠ Ne pas arrêter les antirétroviraux au diagnostic de grossesse ; la voie basse n'est pas une CI absolue (dépend de la charge virale)*

□ Vu : Jt24, Nv24, J19

Prise en charge après un viol / abus sexuel (sérologies & traitement) :

- Sérologies : TPHA-VDRL (syphilis), hépatites B et C, VIH 1 et 2, $\pm$ Chlamydia
- Traitement : antibioprophylaxie IST (azithromycine/doxycycline), contraception d'urgence, trithérapie antirétrovirale, $\pm$ aciclovir
- Prise en charge pluridisciplinaire psycho-médico-sociale + certificat médical + prélèvements médico-légaux
- *⚠ (NB : ces items sont regroupés sous ce tag dans la banque mais relèvent des situations particulières/médico-légales)*

□ Vu : N25, J23

Incontinence urinaire d'effort (IUE) :

- Survient à la toux/effort, SANS sensation de besoin mictionnel ; favorisée par le prolapsus génital
- Diagnostic clinique ($\pm$ bilan urodynamique)
- *⚠ L'IUE n'est PAS liée à une hyperactivité vésicale (= incontinence par impériosité) ; diagnostic non radiologique*

□ Vu : N26

[RANG 16] SUIVI & SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE

— • ~1.20 Q/examen

Consultation prénatale (CPN) :

- Recherche des facteurs de risque médico-chirurgicaux + dépistages systématiques
- Réduit la mortalité maternelle ; peut être assurée par la sage-femme ; ~1 CPN/mois
- Aide au choix de la voie d'accouchement
- *⚠ Item piège : la CPN AIDE bien à décider de la voie d'accouchement (la proposition contraire est FAUSSE)*

□ Vu : J24, Jt24, Nv24

Bilan biologique de début de grossesse :

- Groupage ABO-Rhésus + RAI, NFS-plaquettes, glycémie à jeun
- Sérologie syphilitique (obligatoire), recherche d'autres sérologies selon contexte
- Au 2e trimestre : test d'HGPO ; au 3e trimestre : protéinurie
- *⚠ La sérologie CMV et le test de Coombs direct ne font PAS partie du bilan minimal obligatoire*

□ Récurrent (bilan minimal = sérologie syphilitique)

Échographies de surveillance :

- 1er trimestre (11–13 SA) : datation (biométrie/LCC), clarté nucale (dépistage chromosomique), chorionicité des grossesses multiples, 1re approche morphologique
- 2e trimestre : échographie morphologique de référence
- 3e trimestre : croissance, quantité de LA, localisation placentaire, présentation → aide au choix de la voie d'accouchement
- *⚠ L'écho du 1er trimestre ne permet PAS une étude morphologique détaillée du cœur ; ce n'est pas l'écho du 3e T qui date la grossesse*

□ Récurrent — vu ~6×

[RANG 17] MENACE D'ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ (MAP) & TOCOLYSE

— • ~1.13 Q/examen

□ Score de Bishop (col) — maturation cervicale

Diagnostic de MAP & score de Bishop :

- MAP = contractions utérines régulières + modifications cervicales entre 22 et 37 SA
- Échographie endovaginale (longueur cervicale) pour poser le diagnostic et éviter les hospitalisations inutiles
- Score de Bishop : dilatation, effacement/consistance, position du col, niveau de la présentation (PAS le LA)
- *⚠ Un accouchement imminent et un terme < 22 SA ne définissent PAS la MAP*
- *⚠ Les marqueurs biochimiques (fibronectine) ne sont pas OBLIGATOIRES au diagnostic*

□ Vu : N26, N25, Nv24

Tocolyse — molécules & contre-indications :

- Tocolytiques : inhibiteurs calciques (NIFÉDIPINE, de choix), β 2-mimétiques, antagonistes de l'ocytocine
- Corticothérapie systématique si < 34 SA (maturation pulmonaire)
- *⚠ CONTRE-INDIQUÉE si : chorioamniotite, hématome rétro-placentaire, MFIU, souffrance fœtale aiguë, malformation fœtale létale*
- *⚠ L'anémie n'est pas une CI ; tocolyser sur une chorioamniotite est une faute*

□ Récurrent — vu ~7×

Facteurs de risque :

- ATCD d'accouchement prématuré, grossesse multiple, malformation utérine, hydramnios, infections
- *⚠ L'anencéphalie/anomalie peut favoriser un hydramnios → MAP, mais le FdR direct reste la surdistension*

□ Vu : J19

[RANG 18] FIBROME UTÉRIN

— • ~1.13 Q/examen

Caractéristiques du fibrome utérin :

- Tumeur BÉNIGNE fréquente, hormono-dépendante (croissance sous œstrogènes) ; plus fréquente chez la femme africaine
- Peut être asymptomatique ; se manifeste surtout par des MÉNORRAGIES (fibrome sous-muqueux/intracavitaire)
- Peut être associé à une hyperplasie/cancer de l'endomètre (hyperœstrogénie commune)
- ⚠ Ce n'est PAS une prolifération carcinomateuse ; la dégénérescence sarcomateuse est RARE
- ⚠ Localisation la plus fréquente : corporéale (PAS l'isthme) ; n'entraîne pas TOUJOURS des métrorragies

□ Récurrent — vu ~6×

Complications & indications chirurgicales :

- Complication la plus fréquente du fibrome sous-muqueux = MÉNO/MÉTRORRAGIES
- Indications opératoires : ménorragies rebelles au traitement médical, volume > 10 cm, compression (urétérale), localisation sous-muqueuse
- Peut ne pas être traité (abstention-surveillance si asymptomatique)
- ⚠ Le fibrome sous-séreux et la multiparité ne sont pas en soi des indications chirurgicales

□ Vu : Jn21, J22, J20

Traitement selon le volume/terrain :

- Fibrome volumineux (10–12 cm) symptomatique → myomectomie (conservateur) ou hystérectomie (femme âgée, multipare, multifibromateux)
- Progestatifs de synthèse : traitement médical symptomatique
- ⚠ Une hystérectomie n'est pas « systématique quel que soit le cas » ; le traitement n'est pas exclusivement médical

□ Vu : N25, Jt24, J19

[RANG 19] GROSSESSE PROLONGÉE & DÉPASSEMENT DE TERME

— • ~1.07 Q/examen

□ Terme dépassé = ≥ 42 SA (surveillance dès 41 SA)

Définition & diagnostic :

- Terme dépassé = grossesse ≥ 42 SA (surveillance renforcée dès 41 SA) ; nécessite une DATATION précise
- Peut être favorisé par une hypothyroïdie maternelle, une anencéphalie
- ⚠ Le diagnostic est impossible sans datation fiable ; ce n'est pas systématiquement une indication de césarienne

□ Récurrent (N26, N25, Ratt25)

Conséquences du dépassement de terme :

- Macrosomie, hypoxie/souffrance fœtale, anomalies de l'ERCF, OLIGOAMNIOS, MFIU
- ⚠ PIÈGE : c'est un OLIGOamnios (pas un hydramnios) ; pas de RCIU (plutôt macrosomie)

□ Récurrent — vu ~9×

Surveillance de la grossesse prolongée :

- Mesure du LA par échographie 2 à 3 fois/semaine ; auto-surveillance des mouvements actifs fœtaux par la patiente
- ERCF rapproché
- ⚠ Pas besoin d'une hospitalisation systématique ni d'un doppler tous les 2 jours par principe

□ Vu : J23, Jn23

[RANG 20] GROSSESSE GÉMELLAIRE / MULTIPLE

— • ~1.07 Q/examen

□ Chorionicité = échographie du 1er trimestre (signe du λ / du T)

Surveillance de la grossesse gémellaire :

- Échographie du 1er trimestre OBLIGATOIRE pour déterminer la chorionicité (signe du λ = bichoriale, signe du T = monochoriale)
- Syndrome transfuseur-transfusé suspecté si discordance du LA entre les jumeaux (grossesse monochoriale)
- Déterminer précocement les modalités et le lieu de l'accouchement ; prévenir le risque d'accouchement prématuré
- *⚠ La chorionicité se détermine TÔT (1er trimestre), PAS au 3e trimestre*
- *⚠ Il existe bien un risque accru d'accouchement prématuré (l'item « pas de risque » est FAUX)*

□ Récurrent — vu ~8×

Dizygote vs monozygote ; complications spécifiques :

- Dizygote (faux jumeaux) : TOUJOURS bichoriale-biamniotique, patrimoines génétiques différents ; risque de grossesse hétérotopique
- Monozygote : risque malformatif accru ; STT (monochoriale-biamniotique), jumeaux conjoints et enchevêtrement des cordons (monochoriale-MONOamniotique)
- *⚠ Une dizygote ne donne PAS de vrais jumeaux et n'est pas monochoriale ; pas d'anastomoses entre 2 placentas distincts*

□ Vu : J23, J21, J20

[RANG 21] ASPHYXIE PÉRINATALE & RYTHME CARDIAQUE FŒTAL (RCF)

— • ~1.07 Q/examen

Définition de l'asphyxie périnatale (per-partum) :

- Associe : pH < 7, mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, score d'Apgar < 4 à 5 min, encéphalopathie anoxo-ischémique
- S'accompagne d'anomalies du RCF
- *⚠ Diagnostic combinant des critères biologiques ET cliniques (pas un seul item)*

□ Vu : O24, Jn21, J18

Interprétation du RCF & anomalies imposant l'extraction en urgence :

- RCF normal : base 110–160 bpm, variabilité 5–25 bpm, accélérations présentes
- IMPOSENT l'extraction : bradycardie prolongée (< 110, ex. 100 bpm), décélérations TARDIVES répétées, ralentissements répétés persistants, rythme sinusoïdal/aréactif
- Tachycardie sévère = base > 160 bpm
- *⚠ Décélérations PRÉCOCES (à l'expulsion) = bénignes (compression céphalique) → PAS d'extraction urgente*
- *⚠ Un rythme réactif, des accélérations répétées, une base à 110 bpm sont rassurants*

□ Récurrent — vu ~10×

[RANG 22] PROLAPSUS GÉNITAL & INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT

— • ~0.93 Q/examen

Physiopathologie, clinique & diagnostic :

- Survient surtout chez la multipare ménopausée ; mécanisme = dégradation du tissu conjonctif de soutien + hyperpression abdominale
- Symptôme le plus fréquent : sensation de « boule vaginale » ; le muscle élévateur de l'anus assure la stabilité pelvienne
- Souvent associé à une incontinence urinaire d'effort
- *⚠ L'étiologie congénitale n'est PAS la plus fréquente ; ne touche pas surtout la femme jeune*
- *⚠ L'IRM dynamique n'est PAS l'examen de 1re intention (diagnostic clinique)*

□ Récurrent (N26, J24, J23)

Complications & prise en charge :

- Complications : ulcération de la muqueuse vaginale, dysurie/troubles de la vidange, infections urinaires récurrentes
- Rééducation périnéale = moyen préventif ; objectifs chirurgicaux : restaurer l'anatomie, améliorer la qualité de vie, prévenir les récurrences
- Choix thérapeutique influencé par l'âge et la gêne fonctionnelle
- *⚠ La chirurgie n'est PAS toujours indiquée ni urgente ; le bilan urodynamique n'est pas systématique*
- *⚠ La cystocèle = colpopcèle ANTÉRIEURE (et non postérieure)*

□ Vu : N26, N25, J22

[RANG 23] ENDOMÉTRIOSE

— • ~0.93 Q/examen

Terrain & syndrome douloureux :

- Femme jeune (souvent < 25–30 ans) ; favorisée par les malformations génitales, l'hérédité, la race blanche
- Douleurs : dysménorrhée SECONDAIRE, dyspareunie profonde, douleurs pelviennes chroniques, douleurs à la défécation (atteinte recto-vaginale)
- Examen clinique souvent normal
- *⚠ Ce n'est pas une dysménorrhée PRIMAIRE ni une dyspareunie superficielle ; pas plus fréquente chez la multipare*

□ Récurrent (N26, N25, Ratt25)

Infertilité, diagnostic & traitement :

- Infertilité par imperméabilité/altération tubaire et dysovulation
- Bilan de 1re intention : échographie pelvienne (kyste « endométriome » finement échogène) ; IRM, coelioscopie (nodules bleutés) en 2e intention
- Traitement : œstroprogestatifs, progestatifs, analogues de la GnRH, chirurgie, FIV
- *⚠ L'endométriose ne donne pas d'« effondrement de l'œstradiol » ni d'« augmentation de la FSH » ; les avortements répétés ne sont pas un signe classique*

□ Vu : O24, Jn21, J23

[RANG 24] CANCER DE L'ENDOMÈTRE

— • ~0.93 Q/examen

□ Classification FIGO du cancer de l'endomètre

Facteurs de risque (hyperœstrogénie) :

- Obésité, nulliparité, HTA, diabète, ménopause TARDIVE, terrain héréditaire (Lynch)
- Œstrogénothérapie SEULE (sans progestatif) ; tamoxifène ; SOPK
- *⚠ La ménopause PRÉCOCE n'est pas un FdR (c'est la tardive)*
- *⚠ Les progestatifs sont PROTECTEURS (l'item « prise de progestatifs = haut risque » est FAUX) ; la multiparité protège*

□ Récurrent — vu ~7×

Clinique & diagnostic :

- Signe d'appel = MÉTRORRAGIES post-ménopausiques ; aussi hydorrhée, leucorrhées, polype accouché par le col
- 1er examen devant des métrorragies post-ménopausiques = échographie endovaginale (épaisseur endométriale) ± hystérocopie
- Diagnostic de CERTITUDE = biopsie d'endomètre (hystérocopie avec biopsie ou curetage biopsique)
- *⚠ Ni le frottis, ni la TDM, ni l'IRM ne donnent le diagnostic de certitude ; le CA19-9 n'est pas le marqueur de l'endomètre*
- *⚠ Le type endométrioïde (type I) est de MEILLEUR pronostic*

□ Vu : Jn23, J21, J18

[RANG 25] SUITES DE COUCHES & ENDOMÉTRITE DU POST-PARTUM

— • ~0.93 Q/examen

Suites de couches normales :

- Période de l'accouchement jusqu'au retour de couches (~6 semaines / 41 jours)
- Lochies physiologiques ; tranchées (contractions utérines douloureuses, majorées par les tétées) ; l'allaitement favorise l'involution utérine
- Chute brutale des œstrogènes/progestérone dans les 1ers jours ; rétention urinaire transitoire possible ; baisse des besoins en insuline
- *⚠ Une contraception œstroprogestative n'est PAS obligatoire (CI relative au post-partum immédiat)*
- *⚠ Des lochies fétides ne sont PAS normales (→ endométrite)*

□ Vu : N25, Ratt25, J24

Endométrite & infection puerpérale :

- Une fièvre du post-partum doit faire évoquer une infection puerpérale/endométrite
- Signe le plus évocateur = douleur à la mobilisation utérine ; se déclare souvent vers J4–J5 ; antibiothérapie
- FdR d'infection puerpérale : délivrance artificielle, RPM, travail prolongé
- Anticoagulation par HBPM après césarienne (risque thromboembolique)
- *⚠ Complications de l'endométrite : pelvipéritonite, synéchie, pyosalpinx (pas une appendicite)*
- *⚠ La rééducation périnéale ne se commence pas « immédiatement » ; la thromboprophylaxie n'est pas systématique pour TOUTES les patientes*

□ Vu : O24, J22, J20, J19

[RANG 26] RUPTURE PRÉMATURÉE DES MEMBRANES (RPM)

— • ~0.87 Q/examen

Complications de la RPM :

- Procidence du cordon, présentations dystociques, infection (chorioamniotite, infection néonatale)
- Complication la plus fréquente = PROCIDENCE DU CORDON (urgence)
- *⚠ L'anencéphalie n'est pas une complication de la RPM*

□ Récurrent (N26, O24, Jn21, J20)

Prise en charge de la RPM (prématurée) :

- Hospitalisation + bilan infectieux ; antibiothérapie (et systématique si streptocoque B au prélèvement vaginal)
- Chorioamniotite = complication redoutable → extraction

- *⚠ Pas de surveillance ambulatoire ; l'extraction n'est pas « toujours par césarienne après 24h » ; pas d'antispasmodique*

□ Vu : N25, Jt24, Nv24, J19

RPM + procidence du cordon battant (cas clinique) :

- 1er temps : GARDER la main en intra-vaginal pour refouler la présentation + acheminer au bloc
- 2e temps : CÉSARIENNE en urgence
- *⚠ Ne pas activer le travail ni laisser évoluer par voie basse*

□ Vu : Jt24, Nv24

[RANG 27] MÉCANIQUE OBSTÉTRICALE & EXPLORATION DU BASSIN

— • ~0.80 Q/examen

Exploration du bassin osseux :

- Pelvimétrie interne (TV) : explore le diamètre promonto-sous-pubien → suspecte une anomalie du bassin
- Radiopelvimétrie/scannopelvimétrie possibles ; la scannopelvimétrie peut être réalisée quel que soit l'âge gestationnel
- Bassin normal si indice de Magnin > 22 cm
- *⚠ La scannopelvimétrie n'est PAS systématique chez toutes les femmes*
- *⚠ Toute anomalie du bassin n'impose PAS systématiquement la césarienne (sauf disproportion avérée)*

□ Récurrent — vu ~7×

Détroit supérieur :

- Limité latéralement par les lignes innominées, en avant par le bord supérieur du pubis, en arrière par le promontoire (disque L5-S1)
- *⚠ Repères anatomiques précis souvent piégés (ailerons sacrés, etc.)*

□ Vu : N26

[RANG 28] PRÉSENTATION DU SOMMET

— • ~0.80 Q/examen

□ Repère = occiput (petite fontanelle) ; diamètre = sous-occipito-bregmatique (9,5 cm)

Caractéristiques de la présentation du sommet :

- Présentation la plus fréquente, eutocique ; FLEXION maximale de la tête
- Repère = occiput (petite fontanelle/lambda) ; diamètre engagé = sous-occipito-bregmatique (9,5 cm)
- Variété la plus fréquente : occipito-iliaque gauche antérieure (OIGA) ; diagnostic de variété par le TV
- *⚠ Le repère est la petite fontanelle (occiput), pas la grande fontanelle ; ce n'est pas l'occipito-bregmatique*

□ Vu ~6× (N26, O24, J22, J21)

Mécanique de l'accouchement :

- Engagement = franchissement du plus grand diamètre au détroit supérieur (asynclitisme, signe de Farabeuf) ; diagnostic par TV
- Descente + rotation au détroit moyen ; dégagement en occipito-pubien (occipito-sacré possible dans les variétés postérieures)
- Les variétés postérieures peuvent tourner spontanément
- *⚠ L'épisiotomie n'est PAS obligatoire/systématique*
- *⚠ Les variétés postérieures ne sont pas les plus fréquentes et n'imposent pas la césarienne*

□ Vu : J24, O24, J18

[RANG 29] TUMEURS DE L'OVAIRE

— • ~0.80 Q/examen

□ Classification FIGO — preuve histologique obligatoire

Démarche diagnostique :

- Toute tumeur ovarienne nécessite une PREUVE HISTOLOGIQUE ; classification (FIGO) péroopératoire/chirurgicale
- Échographie = examen de 1re intention ; CA-125 : intérêt pronostique/suivi (peu spécifique pour le diagnostic)
- Éléments écho de malignité : cloisons épaisses, végétations intrakystiques, ascite, hypervascularisation au doppler
- *⚠ La chirurgie première ne « s'impose pas toujours » ; hystérectomie/annexectomie non systématiques ; classification non « radiologique »*
- *⚠ Un contenu liquide pur est plutôt bénin*

□ Récurrent — vu ~7×

Formes & pronostic :

- Tumeurs bénignes : femme jeune, souvent fortuites, kyste séreux fréquent ; tératome = tumeur germinale bénigne, risque de torsion → coeliochirurgie
- Facteurs pronostiques du cancer ovarien : âge, volume du reliquat tumoral post-op, type et grade histologique, stade FIGO
- *⚠ Le CA-125 n'est pas habituellement élevé dans les tumeurs bénignes ; le Ki-67 n'est pas un facteur pronostique retenu ici ; pas toujours bilatérales*

□ Vu : N26, Ratt25, Jn23

[RANG 30] PRÉSENTATIONS CÉPHALIQUES DÉFLÉCHIES (FACE / FRONT)

— • ~0.80 Q/examen

Présentation de la FACE :

- Présentation céphalique en déflexion COMPLÈTE/maximale ; repère = MENTON ; diamètre = sous-mento-bregmatique
- Favorisée par la multiparité ; au TV on sent le menton, les orbites, le nez
- Accouchement par voie basse possible si rotation du menton en avant (mento-pubien) — peut être eutocique
- *⚠ Ce n'est pas une déflexion « intermédiaire » (= front) ; le repère n'est pas la racine du nez (= front) ; la césarienne n'est PAS systématique*

□ Récurrent (N25, Jt24, J22, J18)

Présentation du FRONT :

- Déflexion INTERMÉDIAIRE ; repère = racine du nez ; au TV : grande fontanelle, racine du nez, arcades orbitaires
- Présentation DYSTOCIQUE → césarienne (incompatible avec la voie basse à terme)
- *⚠ Ne pas tenter de fléchir/manœuvrer ni de stimuler par ocytociques → préparer la CÉSARIENNE*

□ Vu : Ratt25, Jn23, J18

[RANG 31] CYCLE MENSTRUEL, PUBERTÉ & SAIGNEMENTS UTÉRINS ANORMAUX

— • ~0.80 Q/examen

Endomètre & saignements utérins anormaux (AUB) :

- Endomètre = 2 couches (basale + fonctionnelle) ; rôle dans l'hémostase ; source de la majorité des saignements utérins anormaux
- 4 caractéristiques à préciser d'un AUB : durée, fréquence, régularité, volume (classification FIGO PALM-COEIN)
- *⚠ L'endomètre n'est pas formé d'une seule couche ; le rôle des œstrogènes/progestérone n'est pas négligeable*
- *⚠ La couleur n'est pas un des 4 paramètres clés*

□ Vu : J24

Étiologies des AUB selon l'âge :

- Enfant : le VAGIN (plutôt que l'utérus) est le plus impliqué ; vrais saignements utérins → exposition œstrogénique
- Adolescence : anovulation + troubles de coagulation ; grossesse/IST/abus possibles
- Période d'activité génitale : léiomyomes, adénomyose, polypes augmentent avec l'âge ; grossesse/IST
- Post-ménopause : penser au CANCER de l'endomètre, mais aussi atrophie/polypes
- *⚠ Chez l'enfant, les causes néoplasiques ne sont pas les plus fréquentes ; à l'adolescence ce n'est pas le col qui domine*

□ Récurrent (Jt24, Nv24, J24)

SOPK chez l'adolescence :

- Cycles longs/irréguliers (spanioménorrhée) + signes d'hyperandrogénie : hirsutisme, alopecie androgénique, acné
- *⚠ Mastodynies, dysménorrhées et dyspareunies ne sont pas des arguments pour le SOPK*

□ Vu : N25

[RANG 32] TRAVAIL NORMAL & CONTRACTIONS UTÉRINES

— • ~0.73 Q/examen

Contractions utérines (CU) & dystocie :

- CU efficaces si elles entraînent effacement + dilatation du col ; douloureuses à partir d'environ 25 mmHg
- Facteurs augmentant l'efficacité : ocytocine, rupture des membranes
- Dystocie mécanique : macrosomie fœtale, présentation défléchie, bassin rétréci
- *⚠ L'hypocinésie/hypercinésie = dystocie DYNAMIQUE (pas mécanique) ; la fatigue maternelle et les β -mimétiques DIMINUENT l'efficacité*

□ Vu : N26, J19

Étude des contractions (tocographie) & modifications maternelles :

- Tocographie INTERNE = meilleure pour évaluer l'intensité (mais expose au risque infectieux, après rupture des membranes)
- Tocographie externe : facile mais limitée chez l'obèse ; palpation manuelle du fond utérin possible
- Grossesse normale : anémie de dilution, stase urinaire (effet relaxant de la progestérone)
- *⚠ La tocographie externe est gênée chez la femme obèse (l'item « facilement chez l'obèse » est FAUX) ; la stase urinaire est due à la PROGESTÉRONNE (pas l'œstradiol)*

□ Vu : Jt24, Nv24, J19, J18

[RANG 33] CANCER DE LA VULVE & LICHEN SCLÉREUX

— • ~0.67 Q/examen

Cancer de la vulve & VIN :

- Carcinome ÉPIDERMOÏDE = type le plus fréquent ; 2 voies : HPV-induite (VIN usuelles/de haut grade, maladie de Bowen) et non-HPV (sur lichen scléreux)
- Peut survenir AVEC ou SANS HPV ; les VIN de haut grade sont des lésions précancéreuses → exérèse
- *⚠ Ce n'est PAS le 1er cancer de la femme ; l'adénocarcinome n'est PAS le type le plus fréquent ; n'est pas TOUJOURS dû à l'HPV ; ne survient pas surtout chez la femme jeune*

□ Récurent (O24, J23, J22)

Lichen scléreux vulvaire :

- Maladie inflammatoire CHRONIQUE ; fait disparaître les reliefs de la vulve ; diagnostic HISTOLOGIQUE
- Lésion précancéreuse (VIN différenciées, non liées à l'HPV) ; peut récidiver après traitement
- *⚠ Ce n'est pas un cancer invasif ; les VIN différenciées ne sont PAS liées à l'HPV et ne sont pas de bas grade*

□ Vu : J23, Jn23, J21

[RANG 34] MÉNOPAUSE & TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF

— • ~0.60 Q/examen

Péri-ménopause & post-ménopause :

- Péri-ménopause : précède de 5–10 ans l'arrêt des règles ; cycles irréguliers, ↑ FSH
- Post-ménopause : extinction folliculaire, effondrement de l'œstradiol → levée du rétrocontrôle (↑ FSH/LH), test à la progestérone négatif, risque d'ostéoporose
- Clinique : aménorrhée > 12 mois, bouffées vasomotrices, dyspareunie/sécheresse, arthralgies, troubles mictionnels
- *⚠ En post-ménopause LH et FSH ne sont pas normales (elles sont ÉLEVÉES) ; il n'y a pas d'augmentation de la sécrétion lutéale de progestérone*

□ Vu : J24, Jt24, Nv24

Métrorragies post-ménopausiques & THS :

- Métrorragies post-ménopausiques → 1er examen = hystérocopie et/ou échographie endovaginale (éliminer un cancer de l'endomètre)
- THS : l'œstrogène seul ↑ le risque de cancer de l'endomètre ; l'adjonction d'un progestatif diminue ce risque
- Risque de cancer du sein faible mais réel → surveillance
- *⚠ Un ATCD de carcinome mammaire hormonodépendant EST une contre-indication au THS ; le THS n'est PAS systématique*

□ Vu : N26, Ratt25, J24

[RANG 35] MORT FŒTALE IN UTERO (MFIU)

— • ~0.60 Q/examen

Mort fœtale in utero — étiologies & complications :

- Souvent d'origine VASCULAIRE ; en partie évitable par la surveillance prénatale ; problème de santé publique
- Nécessite un bilan de la crase sanguine + une évacuation utérine
- Complications : troubles de l'hémostase/CIVD, hémorragie du post-partum, endométrite, retentissement psychologique, récurrence
- *⚠ Ne nécessite PAS une césarienne en urgence (évacuation par voie basse en règle) ; n'est pas « souvent génétique » (plutôt vasculaire)*

□ Récurent — vu ~9×

[RANG 36] HÉPATITES VIRALES & GROSSESSE

— • ~0.60 Q/examen

Hépatite virale B & grossesse :

- Dépistage par recherche de l'Ag HBs ; conduite selon la charge virale
- Vaccination + immunoglobulines du nouveau-né dès la salle de naissance (sérovaccination) ; accouchement par voie basse autorisé
- *⚠ L'allaitement n'est PAS contre-indiqué si sérovaccination correcte (item « CI absolue à l'allaitement » FAUX dans les corrections récentes)*
- *⚠ La césarienne n'est PAS « toujours la règle » ; l'hépatite B ne donne pas de malformations létales*

□ Récurrent — vu ~7×

Hépatite virale C & grossesse :

- Principal risque = transmission verticale (périnatale, majorée par la RPM/passage dans la filière) ; allaitement autorisé
- *⚠ Pas de fœtopathie malformative ; la césarienne n'est pas systématique*

□ Vu : J22

[RANG 37] AMÉNORRHÉE (PRIMAIRE & SECONDAIRE)

— • ~0.60 Q/examen

Aménorrhée primaire :

- Absence de règles malgré un âge avancé / peut s'accompagner d'impubérisme ; radiographie de la main (âge osseux) dans le bilan
- Avec caractères sexuels secondaires NORMAUX : malformation génitale (imperforation hyménéale, cloison vaginale, aplasie utéro-vaginale de Rokitansky), TBK génitale, syndrome d'insensibilité aux androgènes
- Avec virilisation : hyperplasie congénitale des surrénales, tumeur virilisante (ovaire/surrénale), SOPK
- Un simple retard pubertaire est un diagnostic possible
- *⚠ Une douleur cyclique oriente vers une imperforation de l'hymen (rétention) ; ne pas confondre primaire (jamais réglée) et secondaire*

□ Vu : N25, J24, Jt24, J18

Aménorrhée secondaire :

- Toujours éliminer une GROSSESSE en premier ; éléments clés : IMC, contraception, ATCD obstétricaux, hémorragie de la délivrance transfusée
- Synéchie utérine (post-curetage), hyperprolactinémie, syndrome de Sheehan (FSH/œstradiol effondrés après hémorragie de la délivrance), insuffisance ovarienne prématurée
- *⚠ La pilule n'élimine PAS une grossesse (oublis possibles) ; une hyperprolactinémie est possible même sans allaitement*

□ Vu : J20

[RANG 38] TUBERCULOSE GÉNITALE FÉMININE

— • ~0.53 Q/examen

Tuberculose génitale féminine :

- Agent = Mycobacterium tuberculosis ; souvent secondaire à une TBK pulmonaire ; atteinte tubaire fréquente
- Cause d'INFERTILITÉ (primaire) ± aménorrhée ; diagnostic souvent tardif ; coéloscopie à visée diagnostique

- Traitement = anti-bacillaires (polychimiothérapie antituberculeuse)
- *⚠ L'agent n'est PAS Mycobacterium bovis ; ce n'est PAS une pathologie fréquente ; ne donne PAS de cancer de l'endomètre*
- *⚠ Le traitement ne repose ni sur la spiramycine ni essentiellement sur la chirurgie*

□ Récurrent — réponse souvent B,C,D

[RANG 39] MALADIE TROPHOBLASTIQUE — MÔLE HYDATIFORME

— • ~0.53 Q/examen

Môle hydatiforme complète :

- Hyperplasie trophoblastique DIFFUSE ; caryotype diploïde d'origine PATERNELLE (46,XX) ; pas d'embryon ni de cavité amniotique
- Écho : aspect en « flocons de neige / tempête de neige », vésicules, pas d'embryon ; βHCG très élevés
- Évacuation par curetage aspiratif + surveillance par décroissance des βHCG
- *⚠ L'hyperplasie n'est PAS localisée ; il n'y a PAS d'embryon malformé (≠ môle partielle, triploïde) ; pas de villosités normales dans la môle complète*

□ Vu : Ratt25, J24, J23, J18

Complications de la môle :

- Hémorragie utérine, perforation utérine, toxémie gravidique précoce, complications respiratoires (embolie trophoblastique), évolution vers tumeur trophoblastique gestationnelle
- *⚠ Le sarcome utérin n'est PAS une complication de la môle*

□ Vu : J24, J23

[RANG 40] TOXOPLASMOSE & GROSSESSE

— • ~0.53 Q/examen

Toxoplasmose & séroconversion :

- Maladie bénigne chez la mère mais grave pour le FŒTUS ; transmission materno-fœtale TRANSPLACENTAIRE
- Diagnostic de séroconversion = apparition d'IgG et IgM initialement négatives ; surveillance sérologique mensuelle si sérologie négative
- Traitement préventif (spiramycine/Rovamycine) pendant la grossesse ; surveillance sérologique du nouveau-né
- *⚠ L'IMG n'est PAS obligatoire en cas de séroconversion ; ce n'est pas une indication de césarienne ; le risque varie selon le terme (gravité ≠ fréquence de transmission)*

□ Récurrent (Jt24, O24, Nv24, J21)

[RANG 41] ACCOUCHEMENT SUR UTÉRUS CICATRICIEL

— • ~0.40 Q/examen

Contre-indications absolues à l'épreuve utérine :

- Cicatrice CORPORÉALE ou segmento-corporéale antérieure ; ATCD de rupture utérine ; utérus tri-cicatriciel
- Insertion placentaire sur la cicatrice ; disproportion fœto-pelvienne ; présentations dystociques (front), macrosomie avec diabète avéré
- *⚠ Un ATCD d'accouchement par voie basse après césarienne est plutôt FAVORABLE ; une cicatrice de myomectomie simple et un placenta postérieur ne sont pas des CI absolues*

□ Vu : J24, J23, J21, J18

[RANG 42] PRÉSENTATION DE L'ÉPAULE (TRANSVERSE)

— • ~0.33 Q/examen

□ Repère = acromion ; incompatible avec l'accouchement par voie basse

Présentation de l'épaule (transverse) à terme :

- Repère = ACROMION ; présentation transverse ; INCOMPATIBLE avec l'accouchement par voie basse à terme → césarienne
- L'« épaule négligée » (membres/cordon procident, dystocie constituée) suppose une souffrance/mort fœtale ; TV = clé du diagnostic
- Complications : procidence du cordon, rupture utérine, dystocie, mort fœtale
- *⚠ Le diamètre n'est PAS le sous-occipito-bregmatique (concept de présentation céphalique recopié comme piège)*

□ Vu : N26, Ratt25, J23, Jn23

[RANG 43] PROCIDENCE DU CORDON

— • ~0.20 Q/examen

Procidence du cordon :

- Urgence obstétricale ; anomalies du RCF révélatrices ; CÉSARIENNE en extrême urgence (refouler la présentation, garder la main)
- Procubitus = cordon devant la présentation à membranes intactes (forme clinique) → césarienne prophylactique
- *⚠ Le diagnostic ne repose pas sur l'échographie ; pas de tentative d'accouchement par voie basse en refoulant le cordon ; la corticothérapie ne change pas l'urgence*

□ Vu : J24, J21, J18

[RANG 44] RUBÉOLE & GROSSESSE

— • ~0.13 Q/examen

Rubéole & grossesse :

- Séroconversion = positivité des IgG et IgM initialement négatives ; risque MAXIMAL au 1er trimestre (embryopathie)
- Expose à la fœtopathie/embryopathie (syndrome de Gregg) ; prévention = vaccination AVANT la conception ; discuter l'IMG selon le terme
- *⚠ Le risque malformatif n'est pas « minime » au 1er trimestre (il est majeur) ; ne pas « rassurer, aucun risque »*

□ Vu : N25, J21

[RANG 45] SYPHILIS & GROSSESSE

— • ~0.13 Q/examen

Syphilis & grossesse :

- Peut être responsable de fœtopathie (syphilis congénitale) ; traitement par pénicilline retard (Extencilline) AUTORISÉ pendant la grossesse
- Le traitement antibiotique peut guérir la fœtopathie ; diagnostic sérologique (TPHA + VDRL)

- *⚠ Le VDRL SEUL ne suffit pas au diagnostic (besoin d'un test tréponémique TPHA) ; ce n'est PAS une indication d'IMG (curable)*

□ Vu : Ratt25, J22

[RANG 46] MORTALITÉ MATERNELLE

— • ~0.13 Q/examen

Mortalité maternelle :

- Causes : hémorragie du post-partum, complication du post-partum, insuffisance/retard de prise en charge, aggravation d'une cardiopathie, GEU
- Indicateur majeur de santé publique (objectif de réduction)
- *⚠ Un accident de la voie publique = mort « accidentelle/fortuite », non comptée comme mort maternelle directe*

□ Vu : J19, J18

[RANG 47] RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉRIN (RCIU)

— • ~0.13 Q/examen

Retard de croissance intra-utérin :

- Diagnostic échographique (biométrie) ; harmonieux ou disharmonieux ; induit une redistribution vasculaire (épargne cérébrale)
- Peut se compliquer de MFIU ; pronostic selon le caractère précoce/tardif
- RCIU vasculaire : ↓ flux utéro-placentaire ; prééclampsie ≈ 1/3 des étiologies ; thrombophilie
- *⚠ Le RCIU vasculaire n'est pas secondaire à des malformations fœtales (ça, c'est le RCIU dysmorphique/génétique)*

□ Vu : J18

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

** SCORES, REPÈRES & CLASSIFICATIONS À RETENIR **

Score de Bishop (MAP/déclenchement)	Dilatation + effacement/consistance + position du col + niveau présentation
RCF normal	Base 110–160 bpm • variabilité 5–25 bpm • accélérations présentes
Sommet	Repère occiput • Ø sous-occipito-bregmatique 9,5 cm • flexion maximale
Face	Repère menton • Ø sous-mento-bregmatique • déflexion complète
Front	Repère racine du nez • déflexion intermédiaire • DYSTOCIQUE → césarienne
Siège	Repère sacrum • Ø bitrochantérien 9,5 cm
Épaule (transverse)	Repère acromion • voie basse impossible → césarienne
Cancer du col / endomètre / ovaire / vulve	Classification FIGO
Indice de Magnin	Bassin normal si > 22 cm

** SEUILS & CHIFFRES CLÉS DU CONCOURS **

Marqueur / Critère	Indication
TA ≥ 140/90 après 20 SA + protéinurie ≥ 0,3 g/24h	Prééclampsie (définition)
TA ≥ 160/110 • thrombopénie <100 000 • cytolyse • hémolyse	Prééclampsie SÉVÈRE / HELLP
Oligoamnios : grande citerne < 2 cm / index < 5 cm	→ rechercher RPM + TA/protéinurie
Hydramnios : grande citerne > 8 cm / index > 25 cm	→ diabète, atresie œsophagienne
βHCG > 1500 UI/L + utérus vide (écho EV)	Suspicion de GEU
ECBU ≥ 10 ⁵ germes/mL sans symptôme	Bactériurie asymptomatique (à traiter)
Clarté nucale (11–13 SA)	Dépistage des anomalies chromosomiques
Terme dépassé ≥ 42 SA	Surveillance LA + MAF ; risque MFIU
Corticothérapie de maturation	MAP / RPM < 34 SA
Cancer du col stade IB1	Tumeur limitée au col • bon pronostic • Wertheim + lymphadénectomie

** PIÈGES CLASSIQUES (FAUX qui reviennent) **

- **▲ Placenta praevia** : sang ROUGE, indolore → TOUCHER VAGINAL CONTRE-INDIQUÉ (vs HRP : sang noir, douleur, utérus de bois).
- **▲ Œdèmes des MI** : NI obligatoires au diagnostic, NI signes de gravité de la prééclampsie.
- **▲ Prééclampsie/diabète** : donnent un RCIU / une macrosomie respectivement — JAMAIS l'inverse ; pas de diurétiques ni d'IEC dans la PE.

- **△ Allo-immunisation** : prévention anti-D quand RAI NÉGATIVES (pas positives) ; doppler ACM = anémie FŒTALE, non invasif.
- **△ Liquide amniotique** : la DÉGLUTITION est la voie de RÉSORPTION (pas de production).
- **△ Implant** = progestatif seul (PAS un œstroprogestatif) ; ATCD de cancer du sein/thrombose = CI de la contraception hormonale.
- **△ GEU** : localisation AMPULLAIRE la plus fréquente ; si examen normal et stable → β HCG + écho EV (pas de coéloscopie d'emblée).
- **△ MIP** : tous les examens (NFS, CRP, écho, scanner) peuvent être NORMAUX ; lactobacilles abondants = CONTRE le diagnostic.
- **△ Cancer de l'endomètre** : progestatifs et multiparité = PROTECTEURS ; œstrogènes seuls + obésité + HTA + diabète = à risque.
- **△ RCF** : décélérations PRÉCOCES (expulsion) = bénignes ; décélérations TARDIVES / rythme sinusoïdal = extraction urgente.
- **△ Cardiopathie** : risque d'endocardite NON minime ; voie basse non contre-indiquée si bien tolérée.
- **△ Front & épaule** = présentations incompatibles avec la voie basse → césarienne ; face peut accoucher par voie basse (mento-pubien).
- **△ Toxoplasmose/Rubéole/Syphilis** : séroconversion = IgG+IgM initialement négatives ; syphilis curable (pas d'IMG), rubéole = risque MAJEUR au 1er T.
- **△ MFIU** : évacuation par voie basse (PAS de césarienne en urgence) + bilan d'hémostase.
- **△ Tuberculose génitale** : Mycobacterium tuberculosis (PAS bovis), cause d'infertilité, traitement médical (PAS chirurgie).

**** ARBRES DÉCISIONNELS & CHÂÎNES À MAÎTRISER ****

- Métrorragies du 3e trimestre : VVP + remplissage → NFS/groupage + sang → ÉCHOGRAPHIE (jamais de TV) → césarienne si praevia recouvrant ou HRP avec fœtus vivant.
- RPM + cordon battant : garder la main en intravaginal / refouler la présentation → bloc → CÉSARIENNE en urgence.
- Suspicion de GEU (clinique normale) : β HCG plasmatiques + échographie endovaginale → coéloscopie si confirmée/instable.
- Métrorragies post-ménopausiques : échographie endovaginale (épaisseur) $\pm$ hystérocopie → BIOPSIE d'endomètre (certitude).
- Prééclampsie : ischémie placentaire → $\uparrow$ résistances → HTA + protéinurie → (gravité) HELLP / éclampsie / HRP → seul traitement curatif = extraction.
- Anémie fœtale (AFM) : passage d'hématies → allo-immunisation maternelle (IgG) → doppler ACM → transfusion in utero / extraction.
- Cancer du col : HPV 16/18 → dysplasie (CIN) → carcinome épidermoïde → dépistage frottis+test HPV / IVA → biopsie.

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) — Version 1

Cross-match 750 QEs officielles $\times$ Cours officiel Gynéco-Obstétrique (PDF fourni) + corrections officielles e-qe.online

Banque de 750 QE — 15 sessions — Concours de Gynécologie-Obstétrique

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1 → 47)
- ✓ Déduplication des questions répétées sur 15 sessions (750 QE)
- ✓ FAUX/pièges explicites avec △ (le contenu le plus rentable)
- ✓ Aide-mémoire transversal adapté à la gynéco-obstétrique (scores, seuils, arbres)
- ✓ Croisement avec les corrections officielles de chaque session